

URGENCIAS

Ficha del conjunto de datos de episodios de urgencias

Referencia HUE/URG/2026 • Ficha de conjunto de datos

Conjunto de datos. 9 600 registros • 16 campos • cada registro corresponde a un episodio atendido en el servicio de urgencias • documento de circulación interna.

Este documento recopila, sin análisis ni interpretación alguna, el material descriptivo de un conjunto de datos de episodios atendidos en el servicio de urgencias de un hospital. Se ofrece el diccionario de variables, las tablas de estadísticos descriptivos y una selección de representaciones gráficas, tal y como se obtendrían de una primera exploración del fichero. La lectura, el diagnóstico de la calidad del dato y cualquier conclusión quedan enteramente a cargo del analista. Los tiempos se expresan en minutos y la ocupación como porcentaje de los boxes disponibles en el momento de la llegada.

1 Diccionario de variables

La tabla siguiente enumera los campos del fichero con su definición desde el punto de vista del negocio. No se indica su naturaleza estadística ni el papel que cada uno pueda desempeñar en un análisis posterior.

Campo	Definición de negocio
fecha_llegada	Fecha en que el paciente acudió a urgencias.
estancia_minutos	Minutos transcurridos entre el registro en admisión y el alta del servicio de urgencias.
turno	Turno en que el paciente fue registrado en admisión.
nivel_triaje	Nivel asignado en el triaje según el sistema de clasificación del hospital.
edad	Edad del paciente en el momento del episodio.
ocupacion_urgencias	Proporción de boxes ocupados en el momento de la llegada del paciente. El dato procede del registro operativo y no se somete a revisión manual.
pruebas_solicitadas	Número de pruebas complementarias solicitadas durante el episodio. Se vuelca del sistema de gestión en la misma carga que el resto del fichero.
requiere_interconsulta	Indica si el episodio requirió interconsulta con un servicio especializado.
medicos_turno	Número de facultativos de guardia en el turno correspondiente.
via_llegada	Modo en que el paciente llegó al servicio.
sexo	Sexo registrado en la historia clínica.
comorbilidades	Número de patologías crónicas activas registradas en la historia del paciente. El dato procede del registro operativo y no se somete a revisión manual.
acompanante	Indica si el paciente acudió acompañado.
distrito_residencia	Distrito sanitario de residencia del paciente.

Campo	Definición de negocio
episodios_previos_anio	Número de veces que el paciente acudió a urgencias en los doce meses anteriores.
seguro_privado	Indica si el paciente declara seguro privado complementario. Se vuelca del sistema de gestión en la misma carga que el resto del fichero.

2 Estadísticos descriptivos de las variables numéricas

Se recogen, para cada campo cuantitativo, el número de registros observados, el de ausencias, la media, la desviación típica, el mínimo, los cuartiles y el máximo.

Variable	n	Aus.	Media	D.T.	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.
Estancia en urgencias (min)	9 600	0	222,07	177,66	17,52	103,68	169,41	282,82	1 785,41
Edad (años)	9 600	0	38,76	41,56	-99,00	28,00	46,00	62,00	100,00
Pruebas complementarias solicitadas	9 600	0	1,81	2,23	0,00	0,00	1,00	3,00	18,00
Facultativos en el turno	9 600	0	8,43	3,45	3,00	5,00	8,00	11,00	14,00
Comorbilidades registradas	9 600	0	1,19	1,67	0,00	0,00	1,00	2,00	19,00
Episodios previos en el año	9 600	0	0,90	1,41	0,00	0,00	0,00	1,00	14,00

3 Distribución de frecuencias de las variables categóricas

Para cada campo cualitativo se indica el número de categorías distintas, las ausencias, la categoría más frecuente y su peso relativo.

Variable	Categorías	Aus.	Categoría más frecuente	Frec.
Fecha de llegada	365	0	14/07/2025	40 (0,4 %)
Turno de llegada	3	0	tarde	3 894 (40,6 %)
Nivel de triaje	5	0	4 menos urgente	3 551 (37,0 %)
Ocupación del servicio	663	0	77,3 %	41 (0,4 %)
Interconsulta a especialista	2	0	no	7 466 (77,8 %)
Vía de llegada	13	0	por sus medios	4 921 (51,3 %)
Sexo	2	0	mujer	4 928 (51,3 %)
Acude acompañado	2	0	sí	5 884 (61,3 %)
Distrito de residencia	9	0	distrito 4	1 102 (11,5 %)
Seguro privado complementario	2	0	no	7 956 (82,9 %)

El reparto completo de las dos variables cualitativas con mayor número de categorías se detalla a continuación.

Vía de llegada	<i>n</i>	%
por sus medios	4 921	51,3
ambulancia	1 700	17,7
derivación de primaria	788	8,2
por sus medios	631	6,6
POR SUS MEDIOS	595	6,2
ambulancia	217	2,3
AMBULANCIA	196	2,0
traslado interhospitalario	166	1,7
derivacion de primaria	123	1,3
DERIVACIÓN DE PRIMARIA	116	1,2
derivación de primaria	110	1,1
traslado interhospitalario	21	0,2
TRASLADO INTERHOSPITALARIO	16	0,2
Total	9 600	100,0

Distrito de residencia	<i>n</i>	%
distrito 4	1 102	11,5
distrito 8	1 087	11,3
distrito 5	1 084	11,3
distrito 9	1 077	11,2
distrito 6	1 074	11,2
distrito 3	1 069	11,1
distrito 2	1 050	10,9
distrito 1	1 035	10,8
distrito 7	1 022	10,6
Total	9 600	100,0

4 Representaciones gráficas

Las figuras que siguen se presentan sin comentario. Su pie se limita a identificar las variables representadas.

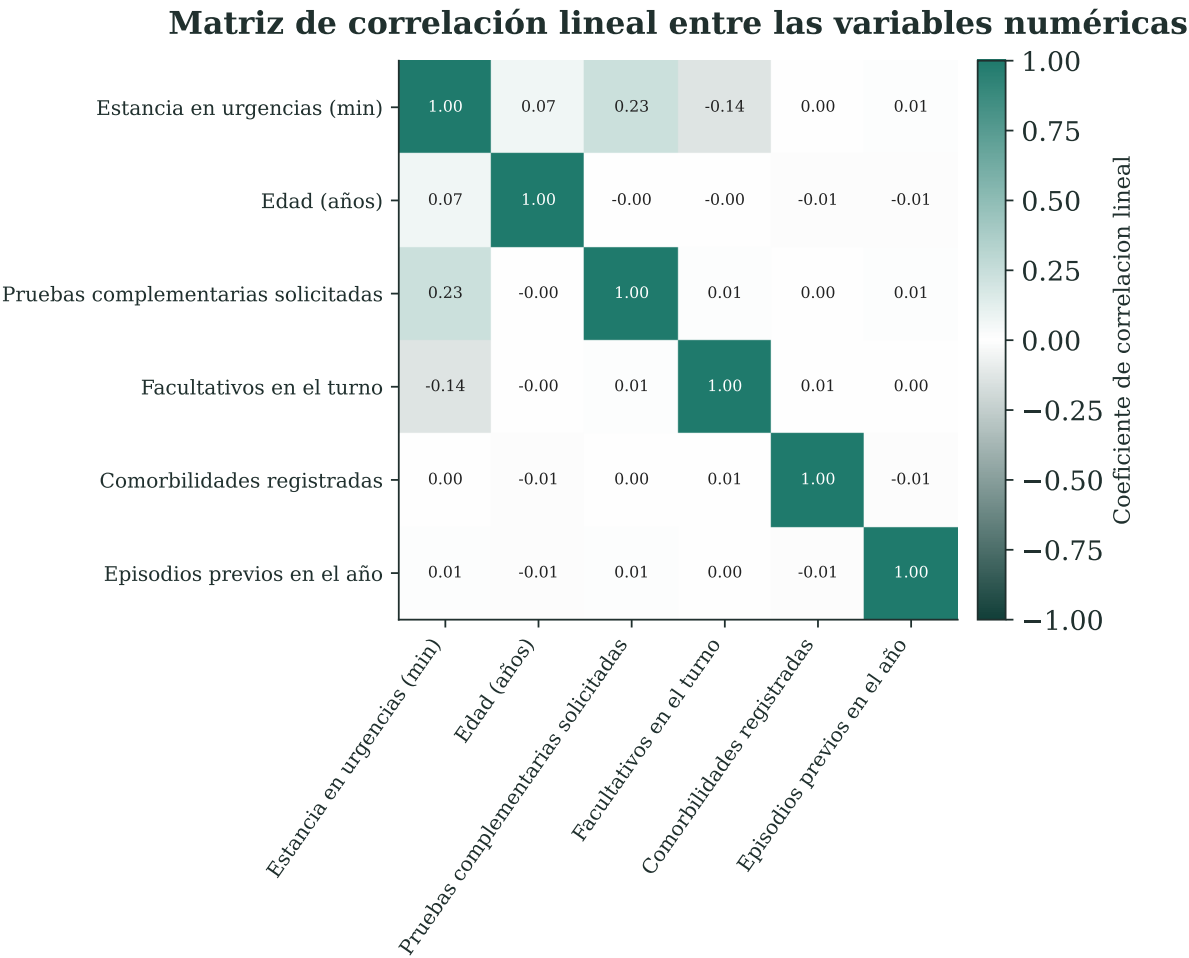


Figura 1. Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas del conjunto.

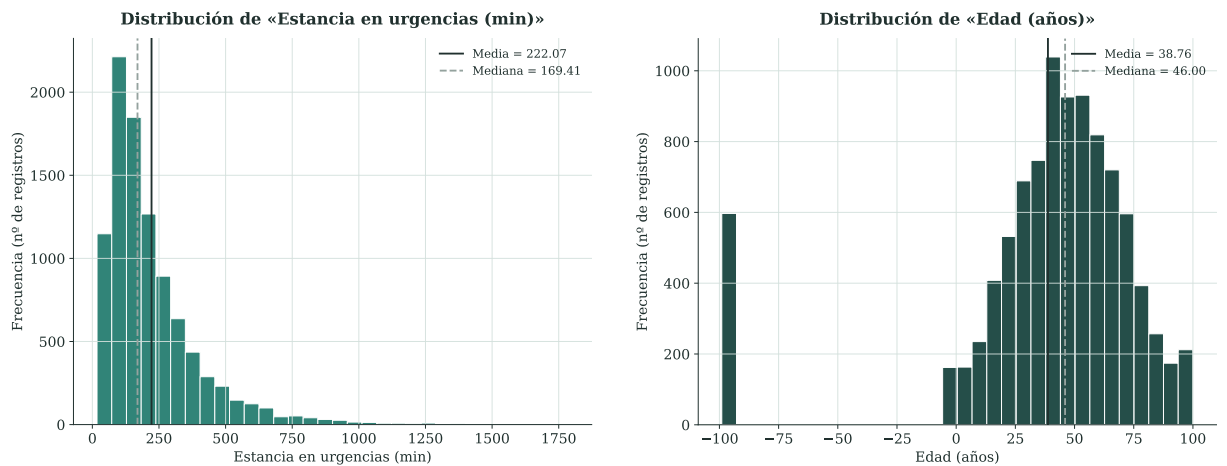


Figura 2. Distribución de «Estancia en urgencias (min)» (izquierda) y de «Edad (años)» (derecha).

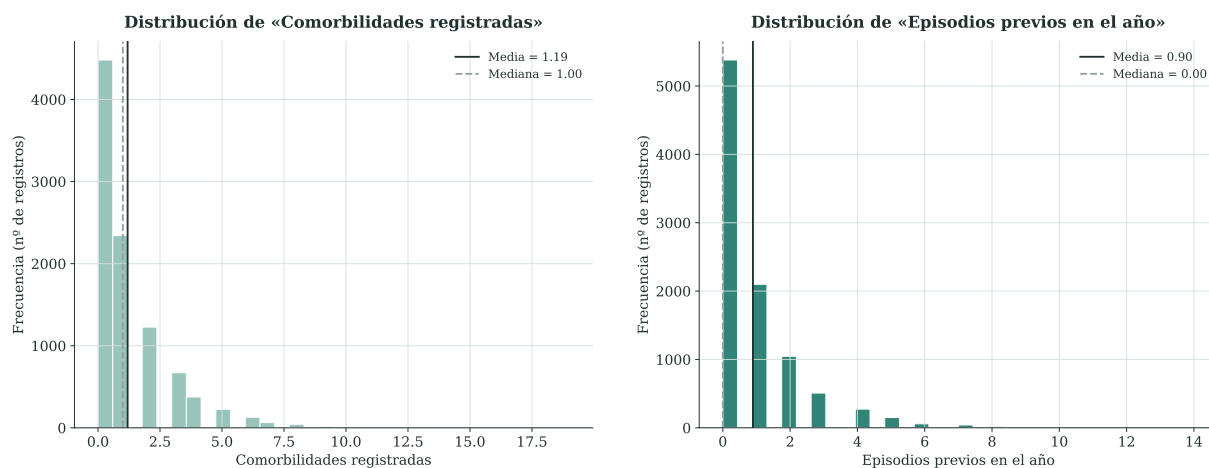


Figura 3. Distribución de «Comorbilidades registradas» (izquierda) y de «Episodios previos en el año» (derecha).

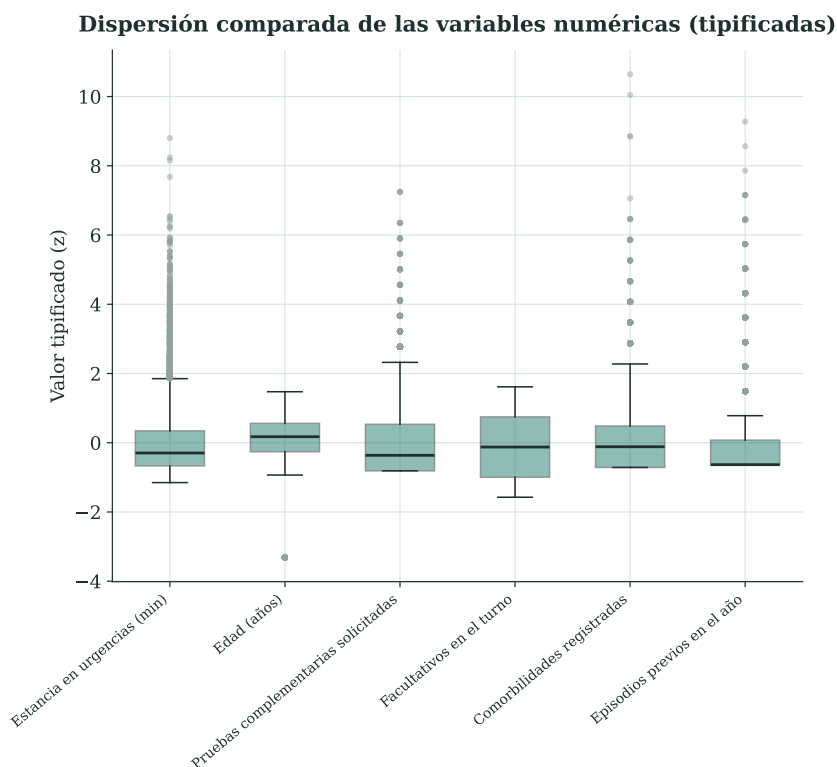


Figura 4. Diagramas de caja de las variables numéricas tipificadas, es decir, expresadas en desviaciones respecto de su propia media.

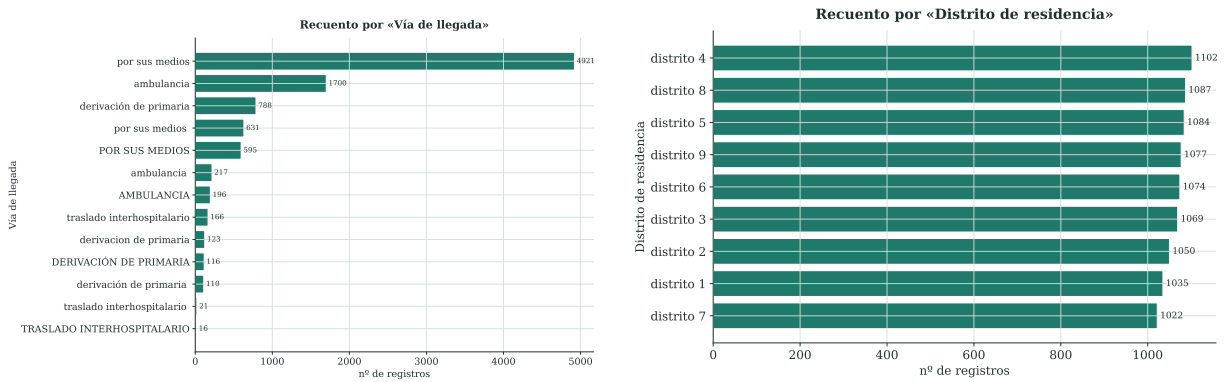


Figura 5. Recuento de registros por «Vía de llegada» (izquierda) y por «Distrito de residencia» (derecha).

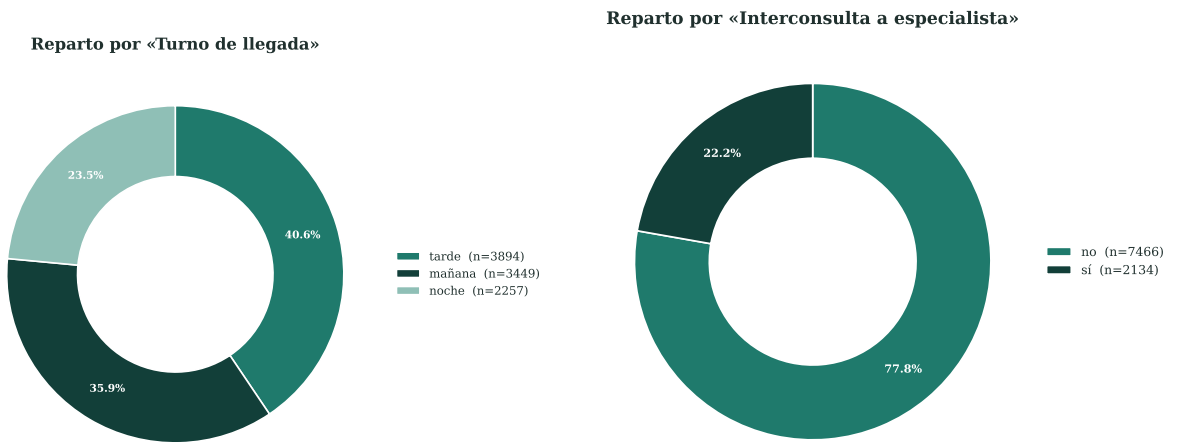


Figura 6. Reparto de registros por «Turno de llegada» (izquierda) y por «Interconsulta a especialista» (derecha).

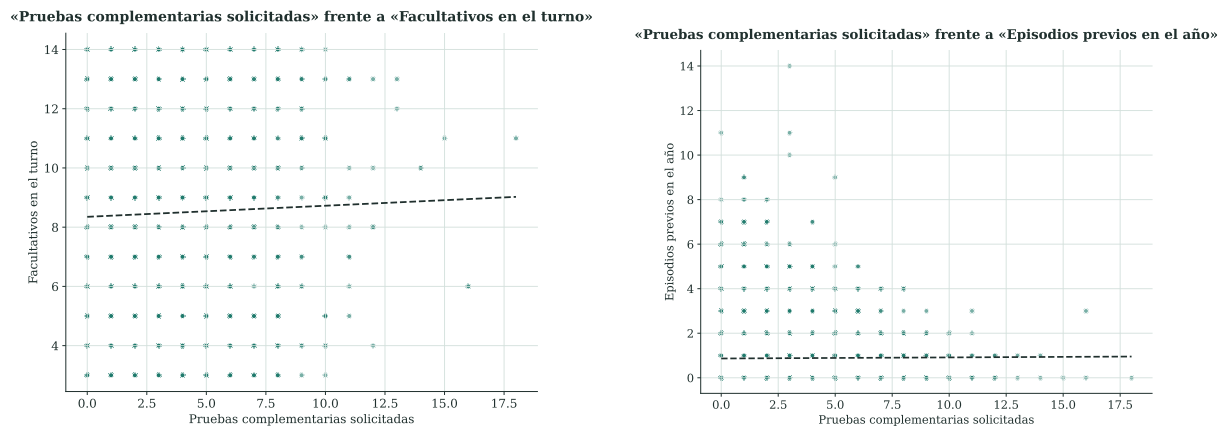


Figura 7. «Pruebas complementarias solicitadas» frente a «Facultativos en el turno» (izquierda) y «Pruebas complementarias solicitadas» frente a «Episodios previos en el año» (derecha).

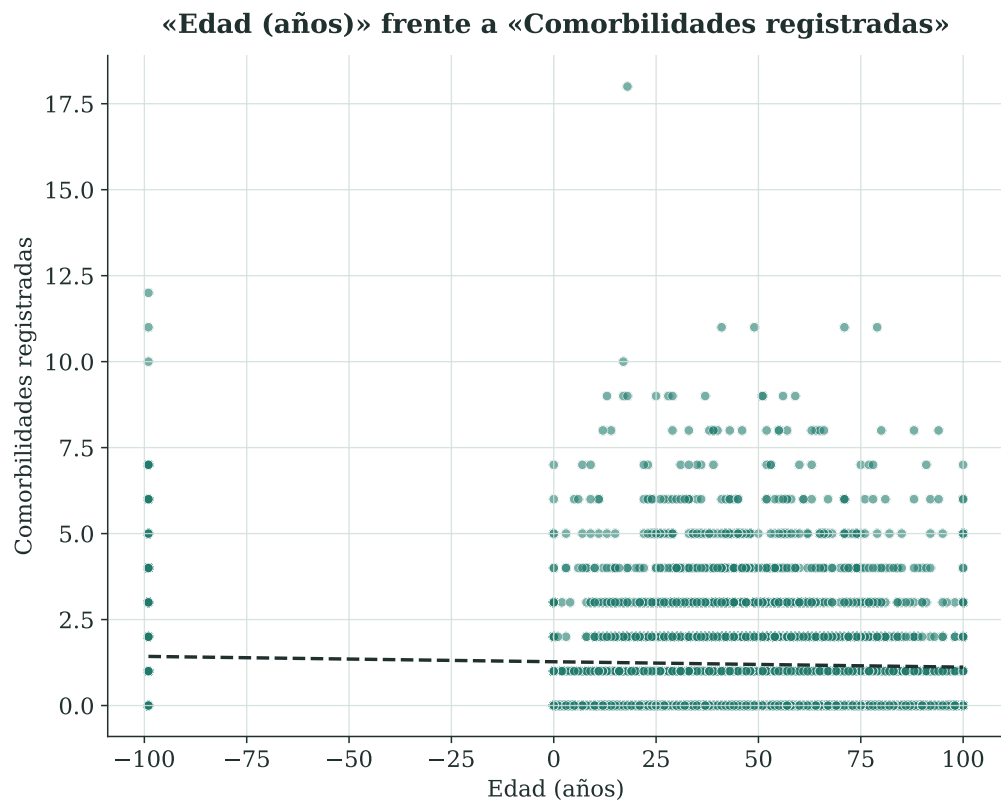


Figura 8. «Edad (años)» frente a «Comorbilidades registradas».

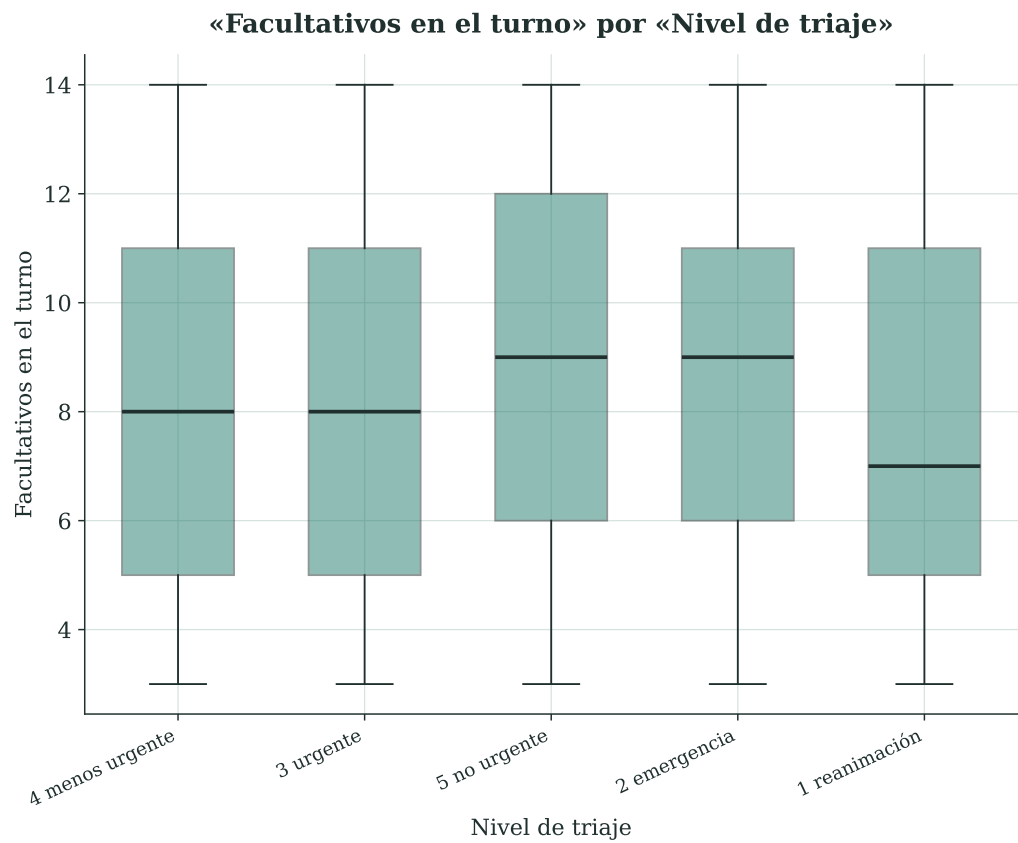


Figura 9. «Facultativos en el turno» desagregado por «Nivel de triaje».

5 Posibles enriquecimientos del conjunto

Reflexión abierta para el analista

Más allá de los campos disponibles, conviene preguntarse qué otras fuentes de información mejorarían el conjunto y qué se ganaría con cada una. Primero, ¿qué información del proceso interno, como la hora de primera atención facultativa o el tiempo de espera de cada prueba, desagregaría la estancia? Segundo, ¿qué datos de destino al alta, como el ingreso en planta o el traslado, explicarían las estancias más largas? Tercero, ¿qué variables de contexto epidemiológico, como la incidencia de gripe o las olas de calor, identificarían los periodos de presión? De todas ellas, ¿cuáles considera factibles de obtener respetando la normativa aplicable y cuáles meramente hipotéticas, y mediante qué número de episodio las uniría al fichero actual?